ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des cinq exercices de synthèse : conseil de planning familial, comparaison de méthodes, étude chiffrée sur la double protection, critique des méthodes naturelles et réponse modèle de restitution organisée. Tous les calculs sont détaillés et vérifiés ; inspire-toi de la rédaction pour le jour du Bac.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : pour les synthèses, compare ton plan et tes phrases au modèle. Au Bac, une bonne réponse = idées correctes + arguments chiffrés + rédaction claire.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac : conseils, comparaisons et rédaction (exercices 1 à 5)

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Conseils, comparaisons et rédaction

✏️ EXERCICE 1 — CONSEIL DE PLANNING FAMILIAL (★★)

Données : Aïcha, 28 ans, 3 enfants, allaite ; espacement souhaité de 3 ans, puis un 4e enfant ; document du centre sur 5 méthodes.

1 **Les familles de méthodes.** Barrière : préservatif. Hormonale : pilule, implant. Mécanique : DIU au cuivre. Chirurgicale : ligature des trompes. On peut ajouter les méthodes naturelles (Ogino, symptothermique).

2 **Critères du dossier.** Allaitement (attention aux hormones), espacement de 3 ans (donc méthode réversible), efficacité élevée (3 enfants déjà nés).

3 **Méthodes adaptées.** Implant : 0,05 %, agit 3 ans, compatible avec l'allaitement, aucune prise à penser. DIU au cuivre : 0,8 %, agit jusqu'à 10 ans, compatible avec l'allaitement, réversible au retrait. La microprogestative est aussi possible, mais la prise quotidienne expose à l'oubli.

4 **Pilule combinée écartée.** Le document indique qu'elle peut diminuer la production de lait, ce qui gêne l'allaitement du dernier-né ; de plus, une prise quotidienne peut être oubliée.

5 **Ligature écartée.** Elle est définitive et irréversible, alors que le couple envisage un quatrième enfant : elle ne peut être proposée qu'à un couple dont le projet d'enfant est clos.

6 **Le conseil rédigé** figure ci-dessous (réponse modèle).

RÉPONSE MODÈLE — CONSEIL DE L'INFIRMIÈRE

« Compte tenu de l'allaitement, de la volonté d'espacer les naissances d'environ 3 ans et du souhait d'un quatrième enfant, je vous conseille un implant ou un DIU au cuivre : ces deux méthodes sont très efficaces, compatibles avec l'allaitement et réversibles. Nous les associerons au préservatif si un risque d'IST existe. La pilule combinée est déconseillée pendant l'allaitement et la ligature est définitive : aucune des deux ne convient aujourd'hui. »

Piège : ne propose jamais une méthode définitive (ligature, vasectomie) à un couple qui veut encore des enfants — c'est un critère d'élimination immédiat.

✏️ EXERCICE 2 — TROIS MÉTHODES À COMPARER (★★)

Données : banque de réponses ; tableau DIU / implant / pilule combinée à compléter.

CRITÈRE	DIU AU CUIVRE	IMPLANT	PILULE COMBINÉE
Famille	mécanique	hormonale	hormonale
Durée d'action	jusqu'à 10 ans	3 ans	une prise quotidienne
Indice de Pearl (usage courant)	0,8 %	0,05 %	9 %
Comment cesse-t-elle d'agir ?	retrait par un soignant	retrait par un soignant	arrêt de la prise
Protège des IST ?	non	non	non

1. **Tableau.** Le DIU est mécanique (sans hormones) ; l'implant et la pilule sont hormonales. Les trois méthodes ne protègent pas des IST : seul le préservatif le fait.

2. **Femme qui oublie sa pilule.** On conseille l'implant (ou le DIU) : aucune prise quotidienne à retenir, efficacité 0,05 % (360 fois meilleure que la pilule en usage courant) et action continue de 3 ans.

3. **Surveillance minimale.** Le DIU : un simple contrôle gynécologique périodique ; l'implant demande de palper la zone de pose ; la pilule exige une prise quotidienne et un renouvellement régulier de l'ordonnance.

4. **Conclusion.** Plus une méthode est « longue durée », moins elle dépend de l'observance : c'est pourquoi implant et DIU ont des indices de Pearl bien inférieurs à celui de la pilule.

✏️ EXERCICE 3 — DOUBLE PROTECTION : IST ET GROSSESSE (★★★)

Données : 120 IST pour 1 000 personnes non protégées ; 12 IST pour 1 000 personnes sous préservatif ; préservatif 18 % en usage courant ; effectifs 5 000 et 500.

1. **Incidences annuelles.** Non protégés : (120 / 1 000) × 100 = 12 %. Sous préservatif : (12 / 1 000) × 100 = 1,2 %.

2. **Réduction relative.** (12 − 1,2) / 12 × 100 = (10,8 / 12) × 100 = 90 %. Le préservatif systématique réduit le risque d'IST de 90 %.

3. **Sur 5 000 personnes.** Sans protection : 5 000 × 12 % = 600 cas. Avec préservatif : 5 000 × 1,2 % = 60 cas. Cas évités : 600 − 60 = **540 cas par an**.

4 **Grossesses.** 500 couples × 18 % = **90 grossesses** en 1 an : le préservatif seul laisse un risque de grossesse notable.

5 **Double protection.** On associe le préservatif (contre les IST) à une méthode très efficace contre la grossesse (pilule, implant ou DIU). Les deux risques sont alors réduits simultanément.

12 % → 1,2 % : réduction de 90 % · 540 cas évités par an · 90 grossesses attendues

Le préservatif protège très bien des IST mais reste une contraception moyenne : d'où la double protection.

Piège : pour la réduction relative, divise la différence (10,8) par la valeur de départ (12) — pas par la valeur d'arrivée (1,2).

✏️ EXERCICE 4 — MÉTHODE D'OGINO : UN COUPLE DÉSACCORDÉ (★★★)

Données : cycles de 25 à 35 jours ; règle d'Ogino (– 18 ; – 11) ; indice de Pearl 25 % en usage courant ; figure 1.

1 **Bornes.** Premier jour fertile : 25 – 18 = 7 → J7. Dernier jour fertile : 35 – 11 = 24 → J24.

2 **Durée de la période fertile.** Du J7 au J24 : 24 – 7 + 1 = **18 jours**.

3 **Proportion sur le cycle court.** 18 / 25 = 0,72 = 72 % du cycle de 25 jours en abstinence (figure 1 : la zone rouge couvre presque toute la barre).

4 **Critique.** Les cycles irréguliers rendent l'ovulation imprévisible : les bornes calculées changent à chaque cycle et doivent être recalculées sur plusieurs mois. Avec un indice de Pearl de 25 %, 1 femme sur 4 débute une grossesse non désirée en un an : méthode trop peu fiable pour ce couple.

5 **Alternatives.** Implant (0,05 %, 3 ans) ou DIU au cuivre (0,8 %, 10 ans) : aucune contrainte calendaire, réversibles. La pilule est possible si la prise est régulière ; le préservatif s'ajoute en cas de risque d'IST.

Période fertile J7 → J24 (18 jours) soit 72 % du cycle court

Plus les cycles sont irréguliers, plus la fenêtre d'abstinence s'élargit : la méthode devient impraticable.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Sujet : « Le choix d'une méthode de régulation des naissances dépend de son efficacité, de la situation de la personne ou du couple et de la protection contre les IST. » Voici la réponse modèle.

1 **Introduction (modèle).** La régulation des naissances est l'ensemble des moyens qui permettent à un couple de choisir le nombre de ses enfants et l'espacement des naissances. Elle repose sur des méthodes d'efficacité inégale : nous verrons que leur choix dépend de l'efficacité, de la situation de la personne et de la protection contre les IST.

2 **Développement 1 — efficacité comparée (modèle).** L'indice de Pearl (% de grossesses non désirées par an pour 100 utilisatrices) classe les méthodes : implant (0,05 %) > DIU (0,8 %) > pilule (9 %) > préservatif (18 %) > Ogino (25 %). L'observance compte : pour la pilule, l'usage courant est 30 fois moins efficace que l'usage parfait.

3 **Développement 2 — situations de vie (modèle).** Pendant l'allaitement, on évite la pilule combinée (elle diminue la lactation) et on choisit implant, DIU ou microprogestative. Chez une femme qui oublie ses prises, on pose un implant ou un DIU. Quand le projet d'enfant est clos, la ligature des trompes peut être discutée ; sinon on garde une méthode réversible. Le planning familial adapte ainsi le conseil au dossier du couple.

4 **Développement 3 — IST et conclusion (modèle).** Seul le préservatif protège des IST (risque réduit d'environ 90 % dans notre étude). La stratégie optimale est la double protection : préservatif + méthode très efficace contre la grossesse. En conclusion, le choix d'une méthode résulte d'un compromis entre efficacité mesurée, situation personnelle (allaitement, oublis, âge, projet d'enfants) et risque d'IST ; le planning familial accompagne ce choix.

📌 GRILLE DE RÉUSSITE (COMME AU BAC)

- ✓ Introduction avec définition + annonce du plan.
- ✓ Trois parties séparées, chacune illustrée d'une valeur chiffrée (indice de Pearl).
- ✓ Phrases complètes, sans abréviations ; conclusion qui répond au sujet.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Revois les formules encadrées et refais les calculs sans regarder le corrigé.